EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON OBESIDAD

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	En la última encuesta de nutrición realizada por el Ministerio de Salud el 59,7 % de las mujeres de 20 a 44 años presentaron sobrepeso y obesidad, y el 77,3 % en el grupo de 45 a 64 años, mientras en el grupo de hombres de 20 a 64 años los resultados fueron de 62,4 % (MINSA, 2013). Posteriormente, la encuesta de vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular indicó una alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población costarricense, 39,5 % y 31,2 % respectivamente (CCSS, 2018). De mantenerse este comportamiento, se espera que para el año 2030 más del 40 % de la población mundial tendría problemas de sobrepeso y más de la quinta parte sería obesa, y en Costa Rica, se prevé que para el año 2060 la prevalencia de sobrepeso en la población será del 94 % (OECD Health Policy Sudies, 2019). Por otra parte, según estudios económicos para la CCSS la atención por obesidad en citas médicas y hospitalización alcanzaron los ₡65 000 millones en el año 2011, sin considerar el impacto que tuvo la pandemia sobre las atenciones por esta enfermedad. Adicionalmente, este grupo de personas con sobrepeso y obesidad tienen un 1,6 veces más riesgo de prevalencia para hipertensión y un 2,3 respectivamente. Se estima que entre el 2020 – 2050 el tratamiento de las enfermedades causadas por la obesidad costará en promedio 8,4 % del gasto total en atenciones médicas. En los países de la OCED el sobrepeso es responsable del 70 % de los costos de tratamiento en Diabetes Mellitus, el 23 % de los costos de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y el 9 % del costo de tratamiento en cáncer. Adicionalmente, a causa de la obesidad se esperan tres millones de muertes prematuras entre personas de 30 y 70 años (OECD Health Policy Sudies, 2019). En este contexto, Costa Rica ha planteado en la estrategia nacional para el abordaje de las Enfermedades no transmisibles y la obesidad (ENTO) una meta que indica actuar sobre el aumento relativo de la obesidad en la población (CCSS, 2023). Asimismo, la CCSS realiza una evaluación de la población con obesidad, con su diagnóstico respectivo y referencia a un profesional en Nutrición, acciones básicas de la atención en la red de servicios de salud. Este tipo de análisis que se obtiene del índice de masa corporal (IMC) se ha realizado en la institución desde el año 2019, como una estrategia para monitorear a la enfermedad en el sistema de salud. Por lo tanto, es momento de reconocer a la obesidad como una patología compleja, recurrente y multifactorial, que requiere de un sistema sólido para su prevención y tratamiento, pero alimentado de un seguimiento permanente y recursos que permitan la toma de decisiones (ElSayed et al., 2023).
Evidencia	El tratamiento recomendado para la persona con obesidad se basa en la modificación del comportamiento o terapia conductual, cuyos objetivos están dirigidos a promover cambios a largo plazo en su comportamiento alimentario con profesionales especializados en nutrición, lo cual involucra tres pilares:

	modificar y controlar su ingesta de alimentos, modificar su actividad física y controlar las señales y estímulos en el entorno que desencadenan comer en exceso (Morgan et al., 2023) (Raynor & Champagne, 2016) (Slawson et al., 2013). La evidencia recomienda a los médicos que ofrezcan y refieran a los adultos con un IMC ≥30 kg/m^2 a intervenciones conductuales y de componentes múltiples (involucran pérdida y mantenimiento de peso basadas en el comportamiento), ya que pueden conducir a mejoras clínicas significativas en el estado de peso, reducir la incidencia de DM tipo 2 y los niveles elevados de la glicemia (US Preventive Services Task Force, 2018) (Freshwater et al., 2022). La evidencia indica (Dobbie et al., 2023): • Un IMC de 40 – 45 kg/m^2 corresponde a una reducción de aproximadamente 10 años en la esperanza de vida. • La motivación de las personas que viven con obesidad para alcanza los objetivos se amplifica cuando hay interacciones positivas con los profesionales de la salud. • La atención primaria juega un papel esencial en el inicio de la evaluación clínica de las personas con obesidad y debe incluir diagnóstico, clarificación del riesgo metabólico, la optimización de las complicaciones asociadas (ej. presión arterial, lípidos, DM tipo 2), así como el inicio de la intervención y la continuidad de la atención a largo plazo. • El manejo de la obesidad debe involucrar a médicos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud relacionadas con la enfermedad (Peckmezian & Hay, 2017).
Consideraciones de Implementación	<u>Barreras:</u> Subdiagnóstico de la obesidad en las áreas de salud. Falta de recurso humano en nutrición en todas las áreas de salud para atender las referencias, lo cual causaría en el personal de salud una posible reducción de referencias emitidas para evitar la saturación del servicio en la red institucional. <u>Estrategias:</u> Sensibilizar al personal en salud sobre la necesidad de consignar el diagnóstico de obesidad en todas las personas que tengan un IMC asociado a la patología, para que estas reciban la atención que el sistema de salud ha definido en la red de servicios según la normativa técnica vigente. Apoyo técnico local y regional en las unidades que así lo requieran para mejorar la atención de las personas con obesidad, lograr mayor equidad y accesibilidad al tratamiento de la enfermedad.
Normativa Técnica	• Lineamiento técnico atención en salud a personas con obesidad en el I Nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2019. • Lineamiento de referencia y contrarreferencia de las personas usuarias de los servicios de consulta externa en los establecimientos de salud de la CCSS. 2020. • Guía usuario módulo de Nutrición consulta externa, 2021. • Estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades No transmisibles y obesidad 2022 – 2030, Ministerio de Salud, 2021.

	• Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad, CCSS, 2023.
Costo / Efectividad	El estudio Look AHEAD demostró la efectividad y reducción en los costos en salud y los beneficios para las personas cuando se someten a un programa de pérdida de peso y modificación de la conducta (Glick et al., 2014). Cada dólar gastado en la prevención de la obesidad genera un beneficio económico seis veces mayor. El tratamiento de la obesidad y sus complicaciones de salud representan una carga económica, ya sea por gastos directos de atención u otros como la pérdida en la productividad laboral, aumento en el consumo de medicamentos, menor ingreso en el hogar (OECD Health Policy Sudies, 2019). Los beneficios logrados en los programas conductuales de control del peso son persistentes durante varios años y deberían alentar a los profesionales de la salud y a los formuladores de políticas a ofrecer tratamientos para la obesidad, ya que se consideran rentables para mejorar el control del peso a largo plazo. Adicionalmente, aumenta la calidad de vida de los participantes (Hartmann et al., 2023).
Objetivo (s) de la Evaluación	Identificar la población adulta con obesidad atendida en el primer nivel de atención que es diagnosticada y referida a Nutrición, para que las unidades tomen las medidas necesarias en el uso eficiente de los recursos disponibles en la red de servicios de salud y las personas reciban la atención requerida.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la proporción de los diferentes grados de obesidad entre la población atendida en el primer nivel según sexo? ¿Cuánto ha mejorado el registro del diagnóstico de la obesidad en la población atendida de 20 a 64 años con un IMC ≥30,0 kg/m^2 entre las RIPSS? ¿Cuál es la proporción de mejora en el registro del diagnóstico de la obesidad entre las RIPSS en comparación con el comportamiento institucional? ¿Cuál es la proporción de personas atendidas con obesidad que son referidas a los servicios de Nutrición para una atención especializada? ¿Existen brechas en el nivel de referencia entre las diferentes RIPSS? ¿Cuáles son probables factores asociados a las brechas de referencia entre las RIPSS? ¿Cuál es la proporción de personas con un IMC ≥30,0 kg/m^2 que tiene algún factor de riesgo cardiovascular adicional a la obesidad que es atendida en el programa PINEC o consulta grupal de Nutrición?
Indicadores asociados a la intervención	05-01-1.0 Porcentaje de personas atendidas de 20 a 64 años con un IMC ≥30,0 kg/m^2 a quienes se les registra el diagnóstico de obesidad. 05-02-2.0 Porcentaje de personas de 20 a 64 años con un IMC ≥30,0 kg/m^2 que son referidas a Nutrición. 05-03-1.1 Porcentaje de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro factor de riesgo cardiovascular, que se atienden en consulta modalidad grupal de Nutrición.

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON OBESIDAD

Anexos	Anexo 1: Clasificación del estado nutricional según IMC, OMS. Anexo 2: Códigos CIE-10 utilizados para obesidad en el EDUS. Anexo 3: Códigos CIE-10 Embarazadas
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2019). Lineamiento técnico atención en salud a personas con obesidad en el I nivel de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica: CCSS, Gerencia Médica, DDSS, Área de Atención Integral a las Personas. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2020). Lineamiento de referencia y contrarreferencia de las personas usuarias de los servicios de consulta externa en los establecimientos de salud de la CCSS. San José, Costa Rica.: CCSS, Gerencia Médica, DDSS, Área de Regulación y Sistematización al Diagnóstico y Tratamiento, Coordinación Nacional de Nutrición. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular. Tercera encuesta. CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Guía de usuario manejo integrado expediente en salud SIES y Módulo de Nutrición. Gerencia Médica, Área de Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad. San José, Costa Rica: CCSS, Gerencia Médica. Data, A. &. D. (2023, 19 mayo). World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323. Dobbie, L., Matta-Coelho, C., Crane, J., & McGowan, B. (2023). Clinical evaluation of patients living with obesity. *Internal and Emergency Medicine*, 18(5),1273-1285. https://doi.org/10.1007/s11739-023-03263-2. ElSayed, N. A., Aleppo, G., Aroda, V. R., Bannuru, R. R., Brown, F. C., Bruemmer, D., Collins, B., Hilliard, M. E., Isaacs, D., Johnson, E. L., Kahan, S., Khunti, K., León, J., Lyons, S. K., Perry, M. L., Prahalad, P., Pratley, R. E., Seley, J. J., Stanton, R. C., & Gabbay, R. A. (2022). 8. Obesity and Weight Management for the prevention and treatment of Type 2 diabetes: Standards of Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S128-S139. https://doi.org/10.2337/dc23-s008 Espeland, M. A., Glick, H. A., Bertoni, A. G., Brancati, F. L., Bray, G. A., Clark, J. M., Curtis, J. M., Egan, C., Evans, M., Foreyt, J. P., Ghazarian, S., Gregg, E. W., Hazuda, H. P., Hill, J. O., Hire, D., Horton, E. S., Hubbard, V. S., Jakicic, J. M., Jeffery, R. W., . . . Zhang, . (2014). Impact of an intensive lifestyle intervention on use and cost of medical services among overweight and obese adults with type 2 diabetes: the action for health in diabetes. *Diabetes Care*, 37(9), 2548-2556. https://doi.org/10.2337/dc14-0093. Freshwater, M., Christensen, S., Oshman, L., & Bays, H. (2022). Behavior, motivational interviewing, eating disorders, and obesity management technologies: an Obesity Medicine Association (OMA) Clinical Practice Statement (CPS) 2022. *Obesity Pillars*, 2, 1000014. https://doi.org/10.1016/j.obpill.2022.100014.

Hartmann, J., Cobiac, L., Theodoulou, A., Oke, J., Butler, A., Scarborough, P., . . . Jebb, S. (2023). Weight regain after behavioral weight management programmes and its impact on quality of life and cost effectiveness: evidence synthesis and health economic analyses. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 25(2), 526-535. doi: 10.1111/dom.14895.

Ministerio de Salud [MINSA]. (2021). Estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022 - 2030. San José, Costa Rica: MINSA.

Ministerio de Salud [MINSA]. (2013). Encuesta nacional de nutrición 2008 - 2009. Fascículo 1: Antropometría. San José: Costa Rica: El Ministerio.

Morgan, M., Raynor, H., Domel, S., Halliday, T., Lynch, A., Malik, N., . . . Rozga, M. (2023). Medical nutrition therapy interventions provided by dietitians for adult overweight and obesity management: an academy of nutrition and dietetics evidence-based practice guideline. *Journal of Academy of Nutrition and Dietetics*, 123(3), 520-545.e10. https://doi.org/10.1016/j.jand.2022.11.014.

OECD Health Policy Studies. (2019). The heavy burden of obesity: The economics of prevention. Paris https://doi.org/10.1787/2074319x: OECD Publishing.

Peckmezian, T., & Hay, P. (2017). A systematic review and narrative synthesis of interventions for uncomplicated obesity: weight loss, well-being and impact on eating disorders. *Journal of eating disorders*, 5(1). https://doi.org/10.1186/s40337-017-0143-5.

Raynor, H., & Champagne, C. (2016). Position of the academy of nutrition and dietetics: interventions for the treatment of overweight and obesity in adults. Journal of the *Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(1), 129 - 147. https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.10.031.

Slawson, D., Fitzgerald, N., & Morgan, K. (2013). Position of the academy of nutrition and dietetics: the role of nutritional in health promotion and chronic disease prevention. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 113(7), 972-979. https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.05.005.

US Preventive Services Task Force. (2018). Behavioral weight loss interventions to prevent obesity-related morbidity and Mortality in adults. *JAMA*, 320(11):1163-1171. doi:10.1001/jama.2018.13022.

World Obesity Federation. (2022). The economic impact of overweight & obesity 2nd edition with estimates for 161 countries. World Obesity Federation.

World Obesity Federation. (2023). World obesity atlas 2023. World Obesity Federation.

Anexo 1 Clasificación del estado nutricional en adultos

Clasificación	IMC
Bajo peso	< 18.5
NORMAL	18.5 – 24.9
Sobrepeso	25.0 – 29.9
Obesidad grado 1	30.0 – 34.9
Obesidad grado 2	35.0 – 39.9
Obesidad grado 3	≥ 40.0

Fuente: WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 1998.

Anexo 2 Códigos CIE-10 para el diagnóstico de obesidad

Código CIE-10	Descripción
E660	Obesidad debida a exceso de calorías
E668	Otros tipos de obesidad
E669	Obesidad, no especificado

Anexo 3 Códigos CIE-10utilizados en embarazadas

Código CIE-10	**Descripción**
Z321	Embarazo confirmado
Z33X	Estado de embarazo, incidental
Z34	Supervisión de embarazo normal Z340-SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO NORMAL Z348-SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES Z349-SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO
Z35	Supervisión de embarazo de alto riesgo Z350-SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ESTERILIDAD Z351-SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ABORTO Z352-SUPERVISION DE EMBARAZO CON RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA Z353-SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE INSUFICIENTE ATENCION PRENATAL Z354-SUPERVISION DE EMBARAZO CON GRAN MULTIPARIDAD Z355-SUPERVISION DE PRIMIGESTA AÑOSA Z356-SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN Z357-SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES Z358-SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO Z359-SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION
Z640	Problemas relacionados con embarazo no deseado
O300	Embarazo doble
O308	Otros embarazos múltiples